



NOTULEN

HARI / TANGGAL : SENIN / 10 MARET 2025
PUKUL : 13.00 – 15.00 WIB
JENIS MEETING : RAPAT KOORDINASI IGD
TEMPAT : HALL SAKURA LANTAI 5

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1	Pokok Bahasan : Arahan dari Dir PT
	Masalah : 1. Memberikan arahan dan mengondisikan unit igd 2. Komitmen dari dokter igd dan perawat 3. Siap mengawal perubahan 4. Selalu perlakukan pasien bagaimana kita ingin diperlakukan 5. Secara administrasi jangan takut, jika ada kesulitan segera dirapatkan sehingga jelas kedepannya
	Keterangan :
	PIC : Kains , yanmed , unit IGD
	Rencana Tindak Lanjut Kains dan pelaksana baik dokter dan perawat bersama-sama dan komitmen untuk pelayanan IGD yang cepat, tanggap dan responsive
No	Penjelasan
2	Pokok Bahasan : Arahan dari dir RS
	Masalah : 1. Dengan adanya perombakan di IGD bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi menjadi evaluasi karena kunjungan dibandingkan persamaan bulan dan tahun lalu, kunjungan yang harusnya naik, tren nya turun dan tidak meningkat secara signifikan 2. Harapannya setelah kains IGD ganti, dan ada perubahan kebijakan atau alur, terutama penerimaan rujukan yang cepat, sehingga branding pelayanan igd yang cepat dan tanggap bisa kembali lagi.
	Keterangan :
	PIC : Kains , yanmed , unit IGD
	Rencana Tindak Lanjut Pelayanan IGD dilakukan monitoring dan evaluasi baik dari perawat maupun dokter, sehingga jika ada yang kurang sesuai, segera di konseling dan di perbaiki
No	Penjelasan
3	Pokok Bahasan : Arahan dari dr. Aji, SpPD
	Masalah : 1. Pasien di ruangan ditanya terkait keramahan, gizi, pelayanan igd, feedback dari pasien adalah puas dengan pelayanan RS 2. Staf tidak membentak, berkata kasar, harus respect dan memperhatikan keluhan pasien 3. Jangan jadikan patokan laboratorium penunjang sebagai penilaian objektif, kondisi klinis juga harus di perhatikan 4. Rujukan dibuat fleksibel, mudah dan tidak terlalu ribet 5. Pasien cepat terlayani, pasien stabil, dan cepat pindah ruangan. Jika tidak stabil atau butuh rujuk, silahkan dikondisikan semaksimal mungkin apabila memang tidak bisa dirawat disini 6. Berikan branding bahwa igd cepat, nyaman, pasien tidak takut, tanggap



	7. Kondisi klinis yang bisa dirawat inapkan silahkan dirawat, apabila ada kesulitan, bisa konsul dr Aji atau yanmed 8. Pemeriksaan elektrolit mahal, review tarif yg dibutuhkan. Misal kalium saja disesuaikan dengan kebutuhannya apa agar tidak over plavon 9. Plafon bukan patokan tetapi emergency pasiennya lebih digali, apakah ada indikasi rawat inap 10. Untuk kasus obstetri dan ginekologi, bidan boleh membantu konsul dan menulis SBAR, tetapi harus seijin dokter igd 11. Dokter igd harus tau kasus OBGYN baik melahirkan, curet atau SC cito dan paham pasiennya kondisinya seperti apa, jadi tidak menyerahkan semuanya ke bidan. Karena dokter jaga igd harus bertanggungjawab ke semua pasien di tiap shift nya. Sehingga pelayanan pada pasien bisa sesuai dengan aturan yg sesuai standart dan meminimalisir reaksi dari DPJP yg marah karena ada laporan atau konsulan yang mungkin sesuai
	Keterangan :
	PIC : Unit IGD
	Rencana Tindak Lanjut
	Pelayanan IGD akan di evaluasi selama 3 minggu berjalan.
No	Penjelasan
4	Pokok Bahasan : Penulisan SBAR
	Masalah : Penulisan SBAR masih belum sesuai
	Keterangan :
	PIC : Dokter dan Perawat
	Rencana Tindak Lanjut
	Yang menulis SBAR adalah DOKTER, apabila crowded, boleh dibantu untuk dituliskan perawat, tetapi harus di supervisi dan dilihat kembali oleh dokter IGD.

Pemimpin Rapat

(dr. Adhya Aji, SpPD)

Malang, 11 Maret 2025

Notulis

(Puput Sekar nariratih, Amd, Keb)

Mengetahui,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada

dr. Nur Mazidah

DOKUMENTASI

